

## • 不合理处方分析 •

### 引起不良理化变化的药物相互作用(二)

张 芳 徐建军<sup>△</sup>

266011 青岛市市立医院药剂科

处方 3            泰胃美与伊曲康唑  
泰胃美            0.4×40 0.4bid po  
伊曲康唑          0.1×6 0.2qd po

分析:本方为一胃溃疡患者服用泰胃美(西咪替丁缓释片)期间患念珠菌性阴道炎,服伊曲康唑后抗真菌疗效不够满意。伊曲康唑为三唑类抗真菌药,在酸性环境中较易吸收,而泰胃美为组胺 H<sub>2</sub> 受体拮抗剂,抑制胃酸分泌作用较强,使胃液 pH 值升高,伊曲康唑的吸收降低,从而影响疗效。另外,抗酸剂如氢氧化铝等也能干扰伊曲康唑的吸收。

处理方法:服用伊曲康唑至少 2 小时后再服用泰胃美,或将伊曲康唑与可乐饮料同服。

处方 4            钙尔奇 D 与维生素 E  
维生素 E            0.1×200 0.1tid po  
维脑路通            0.1×200 0.2tid po  
钙尔奇 D            0.6×90 0.6bid po

分析:本方为一冠心病、动脉硬化患者服用维生素 E、维脑路通期间因骨质疏松补充钙剂。钙尔奇 D 的主要成分为碳酸钙,还含少量维生素 D<sub>3</sub>,用于防治慢性缺钙症。维生素 E 分子结构中的羟基,能与钙离子

络合,生成维生素 E—钙的络合物。从而两药的肠道吸收均减少,疗效降低。另外,维生素 E 与含钙离子的其他药物如葡萄糖酸钙也能产生反应。

处理方法:两药不宜同服,可隔 2 小时以上服。

处方 5            氧氟沙星与乙酰唑胺  
乙酰唑胺            0.25×100 0.25tid po  
氧氟沙星            0.1×36 0.2bid po

分析:本方为一青光眼患者服用乙酰唑胺期间因外伤预防感染口服氧氟沙星,服用氧氟沙星 1 天后出现结晶尿、腰痛,停药氧氟沙星后多喝水,症状消失。乙酰唑胺为碳酸酐酶抑制剂,产生利尿作用,排出碱性尿,而氧氟沙星的溶解度随 pH 值的升高而下降,在尿液中析出结晶,导致肾脏损害。另外,氧氟沙星、诺氟沙星等与碱化尿液的其他药物如碳酸氢钠合用也会产生此类不良反应。

处理方法:两药应避免同一时期服用,应改用其他抗菌药。

(2000-11-03 收稿)

[于小雪 编发]

<sup>△</sup> 青岛市第三人民医院(266000)

线表现明显好转。

3.3 鉴别诊断 引起关节骨质破坏的疾病很多,常见的有化脓性关节炎、退行性骨关节炎等。

3.3.1 化脓性关节炎 是较为严重的急性关节病,X 线表现为关节软骨和骨性关节面破坏较关节结核早且程度严重,因此早期即出现关节间隙变窄。其骨性关节面破坏以承重部分出现早而且明显。这与关节结核发病缓慢、骨质破坏居关节面边缘、关节间隙变窄出现晚的特点不同。

3.3.2 退行性骨关节病 又称骨关节炎,系因关节软骨退行性变而引起的一种慢性骨关节病,分为原发性

与继发性两种。前者是由关节软骨自然老化所致,多见于老年人;后者则系关节软骨长期慢性损伤,如搬运工、运动员以及外伤、感染等而引起的关节软骨退变。由于关节软骨破坏、变性,所以 X 线表现为关节间隙变窄,关节面变平,骨性关节面增生、硬化、关节面边缘形成骨赘,骨性关节面下骨质出现囊样透光区,但关节囊及软组织不肿胀,邻近骨骼和肌肉不萎缩,这些都与以骨质疏松和骨质破坏为主的关节结核有所不同,不难诊断。

(2000-11-15 收稿)

[范存斌 编发]